UE6 - TSSI - CCMP 2021-2022

Sujet (sans correction) - 40 questions

Description

Une jeune patiente de 20 ans, d'origine bretonnne, vient vous voir à votre consultation médicale car elle se plaint d'etre très fatiguée notamment depuis un mois et d'une dyspnée d'effort progressive au 2eme étage, accompagnée d'une tachycardie à l'effort.
Elle n'a jamais été fatiguée de la sorte, elle ne peut plus faire sa journée de travail scolaire sans un repos prolongé à mi-journée.
L'inspection du visage vous frappe d'emblée, à l'entrée dans votre bureau de consultation. Le vosage de la patiente est montrée ci-dessous.
L'entretien médical révèle l'existence de règles abondantes, imposant 12 changes par jour à J1 et J2 des règles.La patiente n'en avait pas souhaité en parler à un médecin antérieureurement
L'examen clinique est normal, sans anomalie de l'examen cardiaque, pleuro-pulmonaire, ni adénopathie ni splénomégalie.



Question **1**

Noté sur 1,00

Dans ce contexte clinique, quel examen complémentaire réalisez-vous en priorité afin de confirmer votre orientation syndromique.

- a. Une bilirubinémie totale et directe
- b. Une radiographie pulmonaire de face
- c. Un hémogramme
- d. Un électrocardiogramme en urgence
- e. Une vitaminémie B12

Question **2**

Noté sur 1,00

Devant le syndrome anémique clinique exprimé chez cette jeune patiente, vous prescrivez la réalisation d'un hémogramme.
Vous en recevez ses résultats qui sont donnés ci-dessous: :

- Taux d'hémoglobine Hb = 7, 5 g/dL, VGM = 71 µ3, TCMH = 23 pg ; réticulocytose à 45 Giga/L.
- Plaquettes numérées à 510 Giga/L.
- Taux de leucocytes 6,5 Giga/L faits de 3,6 Giga/L de polynucléaires neutrophiles: 0, 3 Giga/L de polynucléaires éosinophiles, 0, 7 Giga/L de monocytes, 1, 9 Giga/L de lymphocytes.
- Vous analysez dans votre bureau médical les résultats de l'hémogramme.
- Il existe:

- [ ] a. une neutropénie
- [ ] b. une anémie normocytaire arégénérative
- [ ] c. une anémie hypochrome
- [ ] d. une hyperplaquettose
- [ ] e. une anémie microcytaire

Question **3**

Noté sur 1,00

L'hémogramme vous conduit à envisager un déficit de la synthèse de l'hémoglobine érythrocytaire durant la diiférentiation érythroblastique, en rapport avec un trouble du métabolisme du fer.
Afin de confirmer cette hypothèse physiopathologique, vous devez réaliser:

- [ ] a. un dosage de la vitamine B9 intra-érythrocytaire
- [ ] b. un dosage de la ferritinémie
- [ ] c. un dosage isolé de la transferrinémie
- [ ] d. une fibrinogénémie
- [ ] e. un coefficient de saturation en fer de la transferrine

Question **4**

Noté sur 1,00

La ferritinémie est dosée à 6 µg/L. la fibrinogénémie est dosée à 2 gr/L (normal < 4, 5 g.L). Le coefficient de saturation en fer de la transferrine est à 5%.
Vous envisagez la physiopathologie du syndrome anémique clinique, confirmé à l'hémogramme.
Il s'agit:

- a. • Une carence en vitamine B12 par perte gynécologique
- b. • Une inflammation aiguë
- c. • Un syndrome thalassémique constitutionnel
- d. • Une carence en fer par déperdition chronique globulaire d'origine muqueuse gynécologique
- e. • Une carence en fer par trouble de l'alimentation

Question **5**

Noté sur 1,00

La patiente vous interroge sur le mécanisme physiopathologique responsable de ses troubles cliniques qui, maintenant, perturbent ses activités scolaires et ne lui permettent plus de vivre une vie sportive et scolaire normale.
Vous expliquez qu'il est nécessaire de rechercher:

- a. Une origine hépatique nécessitant un bilan hépatique et une échographie du foie et des voies biliaires
- b. Une origine alimentaire nécessitant une consultation diététique
- c. Une origine digestive nécessitant une fibroscopie gastrique et colique
- d. Une origine gynécologique nécessitant une consultation gynécologique
- e. Des soustractions sanguines non avouées nécessitant une consultation psychiatrique

Question **6**

Noté sur 1,00

Une agranulocytose est une chute du taux des polynucléaires neutrophiles à :

- a. < 1, 5 Giga/L
- b. < 0, 5 Giga/L
- c. < 0, 2 Giga/L
- d. < 1, 7 Giga/L
- e. une neutropénie absolue et totale à 0 Giga/L

Question **7**

Noté sur 1,00

Le globule rouge est une cellule anucléée de forme biconcave. Cette forme indispensable à la déformabilité de l'érythrocyte est liée aux protéines du cytosquelette de l'hématie.

L'acquisition d'une forme sphérique anormale du globule (la microsphérocytose héréditaire) est liée à une mutation constitutionnelle d'une protéine du cytosquelette qui se nomme :

- a. • La glycophorine.
- b. • La myosine.
- c. • L'actine.
- d. • La spectrine.
- e. • La protéine 4.1.

Question **8**

Noté sur 1,00

Un jeune patient se réveille un matin et observe une éruption sur ses membres inférieurs. Il est inquiet et il vient vous consulter en urgence.

Il est apyrétique. Il ne prend aucun médicament. Inquiet, il vous consulte en urgence pour l'orientation étiologique de ces lésions diffuses à prédominance déclive.

Ces lésions sont identifiés ci-dessous au niveau du membre inférieur droit.



a. • Un purpura vasculaire infectieux

b. • Un purpura fulminans

c. • Un purpura vasculaire inflammatoire de type vascularite

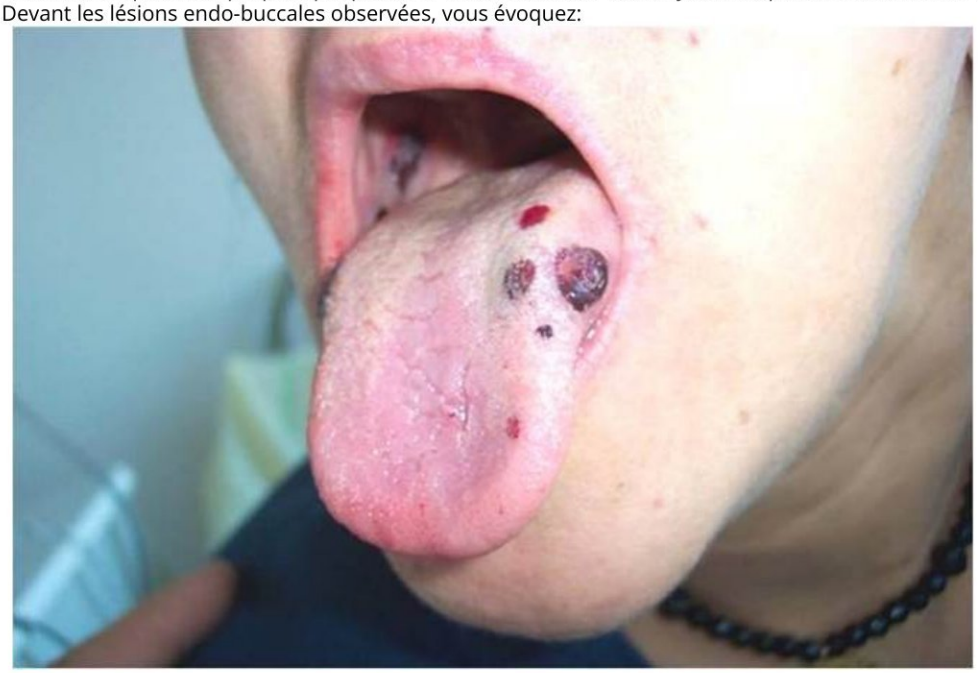
d. • Un purpura plaquettaire

e. • Un purpura vasculaire non infectieux

Question **9**

Noté sur 1,00

Devant la suspicion de purpura plaquettaire, vous réalisez de facon systématique un examen endo-buccal.
Devant les lésions endo-buccales observées, vous évoquez:



- a. • Une candidose buccale à type de muguet
- b. • Un herpès lingual d'origine virale
- c. • Une angine infectieuse streptococcique
- d. • Une glossite atrophique de type glossite de Hunter
- e. • Des bulles hémorragiques jugales et linguales

Question **10**

Noté sur 1,00

Devant l'existence d'un purpura cutanéo-muqueux, qui plus est, associé à l'existence de bulles hémorragiques buccales, vous prescrivez la réalisation d'un hémogramme en urgence.

Vous en analysez les résultats :

Hématies : 4,7 Tera/l ; hémoglobine : 13,8 g /dl ; hématocrite 35 %, VGM 83 fl ; TCMH 27,4 pg ; Plaquettes 15 Giga/l ; leucocytes 6.4 Giga/l, polynucléaires à 3,4 Giga/l, éosinophiles à 0,3 Giga/l, basophiles à 0,1 giga/l, lymphocytes à 2,2 Giga/l, monocytes à 0,4 Giga/l.

L'hémogramme montre:

- a. une anémie normocytaire
- b. une neutropénie
- c. une microcytose
- d. une hypochromie
- e. une thrombopénie strictement isolée, sans aucune autre anomalie à l'hémogramme

Question **11**

Noté sur 1,00

Vous réfléchissez sur la physiopathologie de(s) anomalie(s) observée(s) à l'hémogramme.
Vous proposez une hypothèse physiopathologique la plus probable pour expliquer les résultats de l'hémogramme.

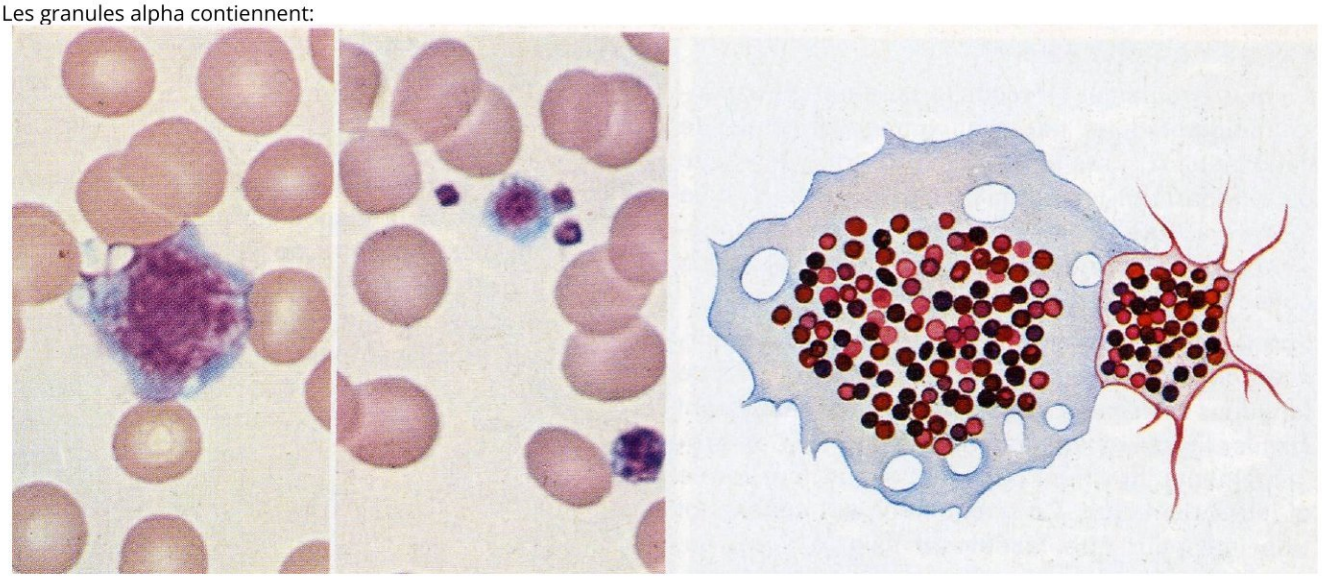
- a. • Une origine centrale pancytopéniante
- b. • Une origine périphérique immunologique
- c. • Une thalassémie
- d. • Une carence en fer
- e. • Une carence vitaminique B12

Question **12**

Noté sur 1,00

Les plaquettes sanguines sont des cellules anuclées qui contiennent des granulations cytoplasmiques de deux types:
1- les granules alpha
2- les granules denses.

Les granules alpha contiennent:



- a. . de l'ADP
- b. . de la sérotonine
- c. . du fibrinogène
- d. . du calcium
- e. . du facteur von Willebrand

Question **13**

Noté sur 1,00

Le facteur intrinsèque (FI) est une protéine nécessaire à l'absorption digestive de la vitamine B12 alimentaire.
Le FI est une glycoprotéine synthétisée par les cellules constitutives des:

- a. • Glandes antrales.
- b. • Glandes de Lieberkhün.
- c. • Glandes pancréatiques.
- d. • Glandes pariétales du fundus gastrique
- e. • Glandes duodénales.

Question **14**

Noté sur 1,00

Le test de Coombs érythrocytaire est un test biologique destiné à :

- a. confirmer une hémolyse
- b. confirmer une hémolyse immunologique
- c. confirmer un déficit vitaminique B12
- d. rechercher la présence d'autoanticorps ou alloanticorps anti-érythrocytaires
- e. rechercher une hémolyse mécanique

Question **15**

Noté sur 1,00

Le phénotype érythrocytaire standard est la détermination du ou des antigènes suivants :

- a. . Antigène C
- b. Antigène c
- c. Antigène Duffy
- d. . Antigène E
- e. Antigène e
- f. Antigène Kell

Question **16**

Noté sur 1,00

Comment sont qualifiés les anticorps du système ABO ?

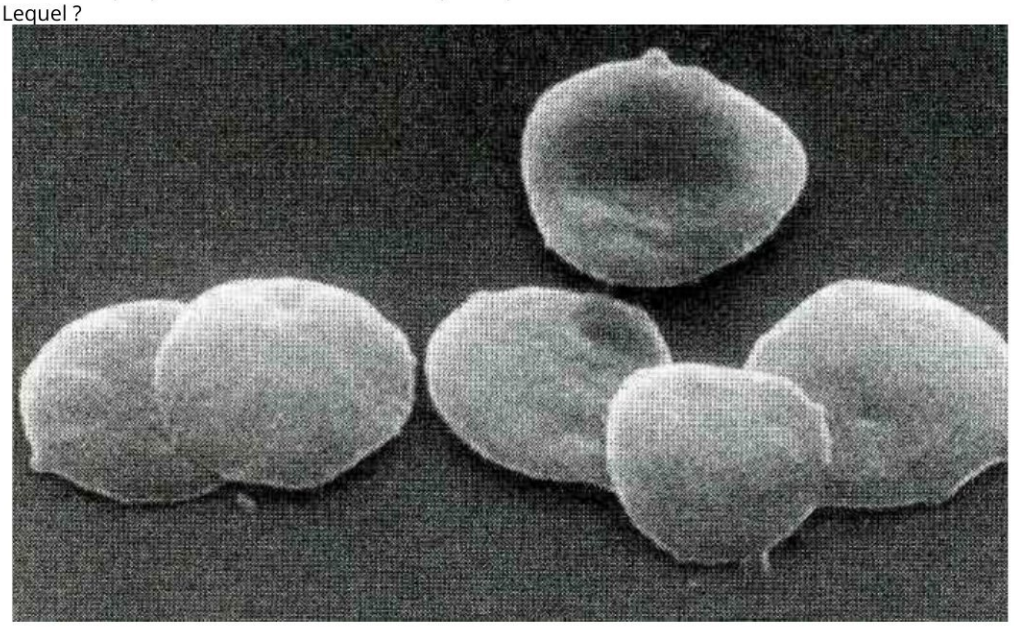
- a. acquis pendant la vie
- b. irréguliers
- c. immuns
- d. naturels et réguliers
- e. transitoires

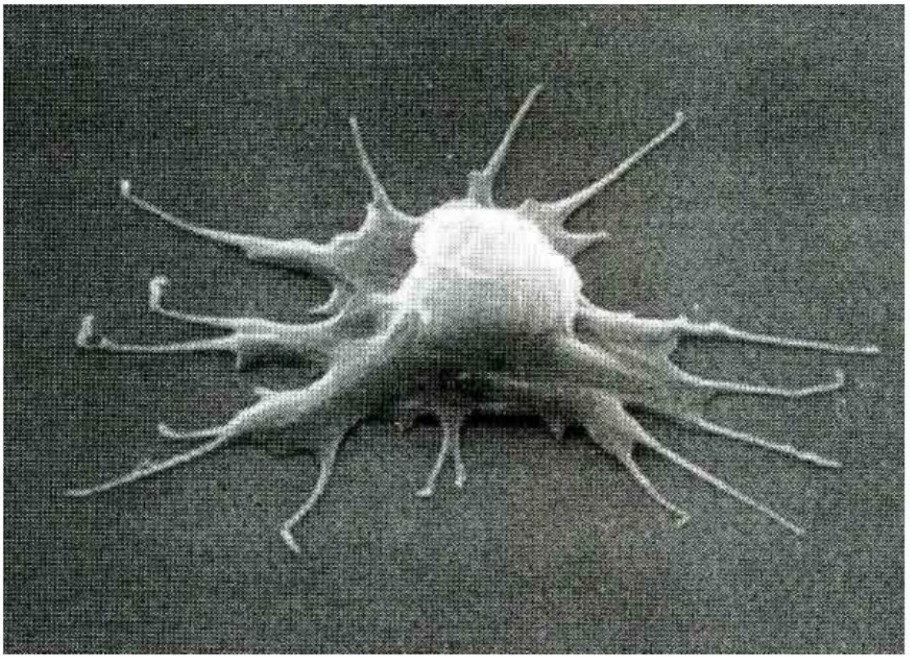
Question **17**

Noté sur 1,00

Le phénomène d'adhésion plaquettaire se met en place lorsque le collagène sous-endothelial est exposé au mileiu circulant, suite à la rupture de la continuité de la barrière endothéliale.

L'adhésion plaquettaire nécessite un facteur protéique.
Lequel ?







- a. Le facteur X
- b. Le fibrinogène
- c. Le facteur von Willebrand
- d. La transferrine
- e. Le facteur VIII coagulant

Question **18**

Noté sur 1,00

Dans quelles circonstances est-il recommandé de transfuser des CGR phénotypés ?

- a. . femme de la naissance à la ménopause
- b. femme de la puberté à la ménopause
- c. recherche d'agglutinines irrégulières positive
- d. patient transfusé de manière répétée
- e. chez tout patient transfusé

Question **19**

Noté sur 1,00

Le récepteur cellulaire au facteur intrinsèque (FI) est exprimé au niveau de la muqueuse:

- a. • Du fundus gastrique.
- b. • De l'antre gastrique.
- c. • De l'Intestin grêle.
- d. • De l'iléon terminal.
- e. • Du jéjunum en D2

Question **20**

Noté sur 1,00

Une femme vient vous consulter car elle est très asthénique depuis une semaine.
Elle a toujours été un femme active.
Son époux a remarqué un changement de l'aspect de son visage et il est inquiet de voir son épouse maintenant inactive et fatiguée.
Elle est apyrétique.
Vous évoquez:



- [ ] a. • Une insuffisance thyroïdienne
- [ ] b. • Une conjonctivite infectieuse bilatérale
- [ ] c. • Un maquillage excessif
- [ ] d. • Un syndrome de cholestase
- [ ] e. • Une hémolyse

Question **21**

Noté sur 1,00

L'existence d'un ictère cutanéo-muqueux doit conduire à envisager deux hypothèses physiopathologiques:

1- un syndrome de cholestase
2- une hémolyse érythrocytaire

Quel examen compémentaire permet de séparer ces deux entités physiopathologiques ?

- ○ a. le dosage des transaminases sériques SGPT et SGOT
- ○ b. Le dosage de la créatininémie
- ○ c. le dosage du taux de la LDH
- ○ d. le dosage de la bilirubinémie totale et de la bilirubinémie directe
- ○ e. le dosage de la gammaGT

Question **22**

Noté sur 1,00

L'hémogramme réalisé montre:

Hémoglobine : 8,8 g /dl ; VGM 88 fl ; TCMH 28,9 pg ; Réticulocytes : 154 Giga/L
Plaquettes 350 Giga/l ;
Leucocytes 6.6 Giga/l, polynucléaires à 3,5 Giga/l, éosinophiles à 0,3 Giga/l, basophiles à 0,1 giga/l, lymphocytes à 2,2 Giga/l, monocytes à 0,5 Giga/l.

Le taux d'haptoglobine réalisé est dosée à 0, 05 gr/l (valeurs normales : 0.50 - 2.50 g/l).
La bilirubinémie libre est à 80 µmoles/L (valeurs normales : 3-12 µmoles/l).
Le taux de la LDH est à 650 UI/L (valeurs normales : 190-430 UI/L).
Le taux de la SGPT (ALAT) est à 35 UI / L (normal : 10 à 49 UI/L). Le taux de la SGOT (ASAT) est a 28 UI/L (normal < 34 UI/L).

A l'aide de ces résultats, vous réfléchissez sur la physiopathologie de(s) anomalie(s) observée(s) à l'hémogramme.

Vous proposez une hypothèse physiopathologique la plus probable pour expliquer les résultats de l'hémogramme.

- a. • Une anémie d'origine centrale et médullaire
- b. • Une hépatite virale ictérique
- c. • Un syndrome de cholestase
- d. • Une anémie hémolytique périphérique
- e. • Une carence vitaminique B9 ou B12

Question **23**

Noté sur 1,00

Qu'est-ce qu'une carte de groupe sanguin valide ?

- a. 1 détermination de groupe sanguin ABO RH1
- b. 2 déterminations de groupe sanguin ABO RH1
- c. 1 détermination du phénotype érythrocytaire
- d. 2 déterminations du phénotype érythrocytaire
- e. Les 2 déterminations sont prélevées à 2 moments différents
- f. Les 2 déterminations sont prélevées en même temps

Question **24**

Noté sur 1,00

Vous voyez un patient de 15 ans en urgence car il présente une fièvre à 39°C et des frissons importants.
La tension artérielle est à 98 mmHg de maxima. Le rythme cardiaque est à 120 battements/minutes.
Le patient présente une photophobie et il est couché dans son lit, en "chien de fusil".
Dans ce contexte de fièvre urgente, vous réalisez un examen cutané. Vous mettez en évidence une éruption des membres inférieurs.Cette éruption est montrée ci-dessous.
L'analyse sémiologique de ces lésions situées sur les deux membres inférieurs vous conduit vers une hypothèse de :



- a. • D'un purpura plaquettaire
- b. • D'un purpura infectieux méningoccocémique
- c. • D'un purpura fulminans
- d. • D'un eczéma aigu nécrotique
- e. • D'un purpura vasculaire non inflammatoire

© 2022 UNESS.fr Tous droits réservés.
Conditions Générales d'Utilisation

Question **25**

Noté sur 1,00

L'hepcidine est une hormone essentielle dans la régulation du métabolisme du fer.
Son role physiologique est:

- a. d'augmenter la biodisponibilité du fer alimentaire
- b. de bloquer l'activité de la transferrine
- c. d'inhiber le transfert transmembranaire du fer de réserve macrophagique vers la transferrine sérique
- d. de réguler négativement la ferroportine
- e. de bloquer tous les transports transmembranaires du fer

Question **26**

Noté sur 1,00

Monsieur T, 67 ans, consulte pour l'apparition semi-récente d'une boule dans le cou qui le gêne quand il se rase. Il ne présente aucun antécédent significatif en dehors d'une hypercholestérolémie traitée par statines depuis 5 ans. A l'examen : Pouls : 65/min, TA : 140/85, température : 37°C. Adénopathies cervicales bilatérales de deux cm, indolores, mobiles, rénitentes. Adénopathie axillaire gauche de 2 cm présentant les mêmes caractéristiques.
Parmi les éléments suivants, lesquels s'inscrivent dans un syndrome tumoral ?

- ☐ a. Adénopathies cervicales
- ☐ b. Adénopathies axillaires
- ☐ c. Hépatomégalie
- ☐ d. Ictère
- ☐ e. Pétéchies

Question **27**

Noté sur 1,00

Parmi les affirmations suivantes, la/lesquelle(s) est/sont exacte(s)

- ☐ a. Une adénopathie cervicale est mobile à la déglutition
- ☐ b. Une adénopathie inguinale doit faire rechercher un cancer des testicules
- ☐ c. Une adénopathie axillaire doit faire examiner la peau du membre supérieur
- ☐ d. Une adénopathie axillaire doit faire examiner le sein homolatéral
- ☐ e. Une adénopathie sus-claviculaire gauche évoque un cancer ORL

Question **28**

Noté sur 1,00

Monsieur T, 67 ans, consulte pour l'apparition semi-récente d'une boule dans le cou qui le gêne quand il se rase. Il ne présente aucun antécédent significatif en dehors d'une hypercholestérolémie traitée par statines depuis 5 ans. A l'examen : Pouls : 65/min, TA : 140/85, température : 37°C. Adénopathies cervicales bilatérales de deux cm, indolores, mobiles, rénitentes. Adénopathie axillaire gauche de 2 cm présentant les mêmes caractéristiques.
Chez notre patient, quelle(s) exploration(s) vous semble(nt) pertinente(s) en première intention ?

- ☐ a. Rechercher une splénomégalie
- ☐ b. Pratiquer un hémogramme
- ☐ c. Pratiquer une biopsie ostéomédullaire
- ☐ d. Pratiquer une laryngoscopie
- ☐ e. Pratiquer une lymphographie bipédieuse

Question **29**

Noté sur 1,00

Un hémogramme est pratiqué et retrouve :

GB 18.6 G/L	Polynucléaires neutrophiles : 25 %
GR 4.9 T/L	Polynucléaires éosinophiles : 1 %
Hb 14.8 g/dL	Lymphocytes : 70 % (petits lymphocytes matures)
TCMH 30.2 pg	Monocytes : 4 %
VGM 96 fl	Présence de nombreux noyaux nus.
Pq 350 G/L	

Quelle(s) est/sont la/ les anomalie(s)

- ☐ a. Anémie
- ☐ b. Microcytose
- ☐ c. Hyperleucocytose à polynucléaires
- ☐ d. Hyperlymphocytose
- ☐ e. Thrombocytose

Question **30**

Noté sur 1,00

A propos des hyperlymphocytoses

- ☐ a. Elles peuvent être dues à des infections virales
- ☐ b. Elles peuvent être dues à une démargination
- ☐ c. Elles se définissent comme un pourcentage de lymphocytes supérieur à 50%
- ☐ d. Elles sont toujours le signe d'une leucémie
- ☐ e. Elles peuvent être phénotypées pour savoir si elles sont mono ou polyclonales

Question **31**

Noté sur 1,00

Un homme de 56 ans fait un hémogramme systématique. *(1 min30, 1.5 points)*

Leucocytes	14 G/L
Hématies	6.5 T/L
Hémoglobine	19.5g/dl
Hématocrite	60%
Plaquettes	600 G/L

Quels signes cliniques vous attendez-vous à trouver

- ☐ a. Céphalées
- ☐ b. Erythrose palmaire
- ☐ c. Adénopathies
- ☐ d. Anesthésie de la houppe du menton
- ☐ e. Splénomégalie

Question **32**

Noté sur 1,00

Une polyglobulie

- a. Est affirmée par la numération formule sanguine
- b. Est affirmée par une mesure isotopique du volume globulaire
- c. Est affirmée par une augmentation de l'éryhtropoïétinémie
- d. Entraîne une hyperviscosité sanguine
- e. Est due à une augmentation des globules blancs

Question **33**

Noté sur 1,00

La maladie de Vaquez

- a. Est un syndrome myélodysplasique
- b. Est liée à une mutation de la tyrosine-kinase JAK2
- c. Peut se compliquer de thromboses
- d. Peut se compliquer de transformation aiguë
- e. Est liée à une insensibilité des progéniteurs à l'érythropoïétine

Question **34**

Noté sur 1,00

Chez ce patient, vous faites un diagnostic de maladie de Vaquez, vous débutez un traitement pour contrôler la polyglobulie et une surveillance clinico-biologique.

Deux mois plus tard, le patient présente une douleur basithoracique gauche brutale. Vous craignez une embolie pulmonaire.

- a. Les embolies pulmonaires constituent une complication classique des maladies de Vaquez
- b. Ce diagnostic est confirmé par un dosage de D-dimères à 2500 ng/ml
- c. Il faut une imagerie pulmonaire (scintigraphie, angioscanner) pour confirmer le diagnostic
- d. Il faut faire un doppler veineux des membres inférieurs
- e. Il faut instaurer un traitement anti-coagulant

Question **35**

Noté sur 1,00

Le patient vous apprend que dans sa famille, deux de ses frères et sa mère ont fait des phlébites, certains dès l'âge de 35 ans. Vous suspectez une thrombophilie familiale

- ☐ a. Il faut faire un dosage de vitamine K
- ☐ b. Il faut rechercher un déficit en antithrombine
- ☐ c. Il faut rechercher un déficit en protéine C
- ☐ d. Les déficits en protéines S n'affectent que les sujets de sexe féminin
- ☐ e. La mutation du facteur II entraîne une résistance à la protéine C activée

Question **36**

Noté sur 1,00

Concernant la thrombose, quelles sont les réponses exactes

- ☐ a. les protéines inhibitrices de la coagulation sont les suivantes : antithrombine, protéines C et S, TFPI
- ☐ b. les éléments de la triade de Virchow sont : lésion endothéliale, stase et hypocoagulabilité
- ☐ c. les anticorps anti-phospholipides sont un facteur de risque acquis de thrombose
- ☐ d. La mutation "Leiden" du facteur V entraîne une résistance à la protéine C activée
- ☐ e. un bilan biologique de thrombophilie doit être réalisé systématiquement devant une embolie pulmonaire

Question **37**

Noté sur 1,00

Le patient est traité par anti-vitamines K. Quels facteurs seront affectés par ce traitement ?

- ☐ a. Facteur VIII
- ☐ b. Protéine C
- ☐ c. Facteur V
- ☐ d. Facteur II
- ☐ e. Facteur X

Question **38**

Noté sur 1,00

Concernant la coagulation, quelles sont les réponses exactes

- ☐ a. la coagulation consiste en une succession de réactions enzymatiques
- ☐ b. les cofacteurs (V et VIII) ont un rôle minime dans les processus de coagulation
- ☐ c. les protéines vitamine K dépendante sont les suivantes : II, VII, IX, X
- ☐ d. le facteur XIII permet de dissoudre le caillot de fibrine
- ☐ e. les ecchymoses sont un symptôme caractéristique d'un trouble de la coagulation

Question **39**

Noté sur 1,00

Concernant l'hémostase primaire, cocher les réponses exactes

- ☐ a. les acteurs cellulaires sont les cellules épithéliales et les plaquettes
- ☐ b. les acteurs plasmatiques sont le facteur Willebrand et le fibrinogène
- ☐ c. les granules plaquettaires ont un rôle minime dans le phénomène d'agrégation plaquettaire
- ☐ d. le récepteur plaquettaire au fibrinogène est la glycoprotéine GPIIbIIIa
- ☐ e. les hémarthroses sont caractéristiques de troubles de l'hémostase primaire

Question **40**

Noté sur 1,00

Un homme de 62 ans consulte pour une pesanteur de l'hypochondre gauche. A l'examen, vous notez une masse de l'hypochondre gauche, vous suspectez une splénomégalie

- ☐ a. La masse est battante
- ☐ b. La masse à un bord antérieur crénelé
- ☐ c. La masse est mobile à l'inspiration profonde
- ☐ d. La masse donne un contact lombaire
- ☐ e. La masse est ligneuse